Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Épistaxis

Saignement de nez, adulte et enfant, hors traumatisme grave du visage : moucher, comprimer 10 min tête en avant, alerter selon les critères.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · saignement abondant qui coule dans la gorge malgré la compression, malaise, pâleur, sueurs, gêne pour respirer.

1 · Je sécurise

- Gants. Installer **assis, tête penchée en avant** ; haricot ou serviette.
- Faire **moucher** doucement pour évacuer les caillots (aider l'enfant).
- Faire **cracher** le sang qui coule dans la gorge, ne pas l'avaler.
- Personne qui ne peut pas s'asseoir : sur le côté, tête légèrement relevée.

2 · J'observe et je mesure

- Heure de début ? Abondance : goutte à goutte ou coule en continu ?
- **Anticoagulant, antiagrégant ?** Choc au nez ?
- Pouls, TA : signaler une TA élevée à l'IDE.
- Pâleur, sueurs, malaise, gêne respiratoire ?

3 · J'agis

- **Comprimer les deux narines** (partie molle du nez) **10 min sans relâcher**, montre en main.
- Saigne encore à 10 min : remoucher, 2e compression de 10 min, prévenir l'IDE.
- Arrêt : repos au calme ; pas de mouchage fort ni d'effort dans les heures qui suivent.
- Enfant : rester avec lui, le rassurer ; prévenir les parents selon le PAI.

Je ne fais pas

- Pencher la tête **en arrière** ou allonger à plat.
- Relâcher pour « vérifier » avant les 10 min.
- Mettre coton, mèche ou produit dans le nez (geste IDE).
- Donner un médicament sans avis de l'IDE.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Saignement **abondant** ou qui coule dans la gorge malgré la compression.
- **Saignement depuis plus de 20 min** malgré 2 compressions bien faites, IDE non joignable.
- Malaise, pâleur, sueurs, pouls > 120/min, PAS < 100 mmHg.
- Saignement après un choc violent au visage ou à la tête.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- Saignement qui reprend après la 1re compression de 10 min.
- Personne sous **anticoagulant** ou **antiagrégant**, même si le saignement s'arrête.
- Épistaxis à répétition ; TA élevée (PAS > 200 mmHg = signe de gravité).
- Choc sur le nez → voir aussi protocole « Traumatisme crânien ».

Je surveille et je trace

- Tracer : heure, durée, côté, abondance, compressions faites, paramètres, qui a été prévenu.
- Récidive dans les heures ou jours suivants → IDE (même si elle s'arrête seule).
- Sous anticoagulant : l'IDE en informe le médecin.

Mention de sécurité

Assis, tête en avant, mouchage puis compression bidigitale 10 min sans relâcher. Plus de 20 min ou abondant = 15 si l'IDE n'est pas là tout de suite.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFORL, recommandations Épistaxis de l'adulte (Ann Fr ORL 2017;134), citées par La Revue du Praticien ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD, Épistaxis (2016) ; ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap, Épistaxis (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-EPIST | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature